



FAMERP | 2023

R1 ACESSO DIRETO

1 - Um trabalhador da área da saúde (enfermeiro) teve sua jornada de trabalho expirada as 18h, quando adentrou em sua motocicleta e se dirigindo para sua residência, lembrou-se de realizar as compras do mês em um supermercado que estava inserido no trajeto, tendo um gasto de aproximadamente 90 minutos para realizá-las, quando então dá início ao retorno para sua residência sofre um acidente projetando-se para o solo e apresentando diversas fraturas de membros superiores, pergunto:

- A) Caracteriza-se como acidente de trabalho de acordo com a legislação vigente.
- B) Caracteriza-se como acidente de trânsito de acordo com a legislação vigente.
- C) Não tenho elementos para caracterizar como acidente de trabalho ou de trânsito.
- D) Tanto pode ser caracterizado como acidente de trânsito ou de trabalho.

2 - O primeiro câncer relacionado ao trabalho descrito pelo médico inglês Percival Pott, em 1975, em trabalhadores que realizavam limpeza de chaminés na Inglaterra, foi o:

- A) Câncer de estômago.
- B) Câncer de pulmão.
- C) Câncer de fígado.
- D) Câncer de escroto.

3 - São exames complementares obrigatórios a serem realizados em trabalhadores que laborem em empresas de processamento de alimentos, e deverão constar no PCMSO das mesmas:

- A) Hemograma, glicemia, parasitológico e urina tipo I.
- B) Parasitológico, glicemia, triglicérides e urina tipo I.
- C) Hemograma, urina tipo I, parasitológico e cultura de fezes.
- D) Eletrocardiograma, hemograma, eletroencefalograma, urina tipo I.

4 - Na ocorrência de Acidente do Trabalho em uma Indústria Metalúrgica teve como consequência óbito do trabalhador: Quais são os procedimentos Legais corretos a serem adotados:

- A) Reunião da CIPA e Membro do Ministério do Trabalho.
- B) Reunião da CIPA + Membros do INSS.
- C) Perícia da Polícia Técnica + Reunião de Emergência da CIPA.
- D) Reunião da CIPA e Membro do Ministério do Trabalho + Membros do INSS.

5 - Um trabalhador de 35 anos de idade do setor moveleiro, é acometido de Acidente do Trabalho

“gravíssimo”, que teve como consequência amputação da mão esquerda e resolveu protocolar uma Ação Indenizatória contra a citada empresa. O Juiz do Trabalho deverá nomear um Perito Médico para avaliar o grau de incapacidade laborativa do empregado acidentado. A Legislação Trabalhista aceita o que segue:

- A) A empresa (Reclamada) e o trabalhador acidentado (Reclamante) através de assistentes técnicos nomeados, poderão cada um assistir e elaborar Parecer técnico da Perícia.
- B) A Justiça do Trabalho não aceita que a empresa e o trabalhador nomeiem ao Processo, assistentes técnicos para acompanhar a Perícia a ser realizada pelo Perito do Juízo.
- C) Somente poderá acompanhar a Perícia Técnica o Perito Médico do juízo e o Advogado da Empresa.
- D) Somente poderá acompanhar a Perícia Técnica, o Perito Médico do Juízo e o Advogado do trabalhador acidentado.

6 - A composição da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) avalia a responsabilidade do Acidente de Trabalho, é correto afirmar que:

- A) 50% dos membros nomeados pela empresa 50% eleitos pelos seus pares.
- B) Os membros eleitos têm estabilidade por 5 anos a contar da posse.
- C) O presidente é nomeado pelos seus pares trabalhadores.
- D) A CIPA emite quinzenalmente um relatório sobre todas as ocorrências inclusive Acidentes do Trabalho e Doenças relacionadas ao trabalho no ano.

7 - Paciente feminina, 55 anos, chega à Unidade Básica de Saúde do seu bairro, para retorno com a Dra. Gabriela. Na primeira consulta referiu desânimo, sem forças para realizar as atividades de casa e com fogacho (“tenho vontade de ficar sem roupa”). Referia também insônia e preocupações com o filho. Após estar cumprindo projeto terapêutico, em comum acordo com a Dra. Carla, a consulta de retorno se desenvolve com o seguinte diálogo:

Dra. Gabriela: – Entre e sente-se, dona Maria, em que posso ajuda-la hoje?

Dona Maria: – Bem, vim para falar que melhorei bastante da fraqueza e do desânimo, o calor no corpo diminui e estou dormindo melhor, depois que a doutora me orientou e passou aqueles remedinhos. Como a doutora falou, acho que logo não precisarei mais do remédio para dormir. Estou bem mais calma.

Dra. Gabriela: – Que bom! Fico muito feliz que as coisas estão melhorando dona Maria. Mantenha por enquanto as orientações que combinamos. Hoje, vou aproveitar a vinda da senhora para pedir alguns exames preventivos. Faz quanto tempo que a senhora não faz uma mamografia?

Dona Maria: – Eu nunca fiz doutora.

Dra. Gabriela: – Depois de examiná-la, vou fazer o pedido então e de mais alguns outros exames importantes para sua idade.

Ao ler esta história fictícia, qual o princípio do SUS e da RAS (Rede de Atenção à Saúde) que foi levado em conta pela Dra. Gabriela nesta consulta na Atenção Básica?

- A) Longitudinalidade do cuidado.

- B) Integralidade da atenção.
- C) Coordenação do cuidado.
- D) Prevenção secundária.

8 - Os serviços e os profissionais de saúde vêm sendo cada vez mais pressionados pelo complexo médico-industrial (indústrias de medicamentos, exames, órteses e próteses), onde o conhecimento científico é transferido do cuidado centrado na pessoa para avaliação e gestão de riscos. Praticamente todos os seres humanos, na maioria das vezes, são taxados de doentes quando procuram atendimento médico. Um dos principais argumentos daqueles que propagam práticas de medicalização da vida é a importância crescente atribuída ao risco, e a confusão que se faz entre risco e doença no dia a dia da prática médica. Baseado nestas afirmações, responda: qual o nível de prevenção que está em jogo nesta constatação?

- A) Prevenção primária.
- B) Prevenção secundária.
- C) Prevenção terciária.
- D) Prevenção quaternária.

9 - Dona da Amil, UnitedHealth se prepara para vender toda operação no Brasil: "Segundo fontes, Rede D'Or, maior rede de hospitais privados do país, seria o maior interessado nos ativos. Os ativos envolvem 15 hospitais e 53 centros ambulatoriais da AMIL e 16 hospitais, 41 clínicas médicas, distribuídos em seis estados brasileiros, com uma estrutura de 2.332 leitos e mais de 17 mil profissionais". O setor da Saúde Suplementar, que possui 48 milhões de consumidores e fatura, aproximadamente, 210 bilhões de reais, em que pese a crise econômica brasileira, está em franco aquecimento e movimentação. Agência O Globo (14/01/2022) Baseado na reportagem acima, responda: quais as tendências do mercado da saúde suplementar apontadas pelas reportagens?

- A) Verticalização da cadeia de produção da assistência à saúde e concentração dos usuários nas grandes operadoras.
- B) Terceirização das operadoras, através da gestão em parceria com hospitais, clínicas e laboratórios, expansão das cooperativas médicas e aumento das práticas liberais em medicina.
- C) Integração da Rede Assistencial, com formas de gestão horizontalizadas e cooperadas entre várias operadoras de uma mesma região e reestruturação do modelo assistencial.
- D) Expansão do número de operadoras de saúde nos últimos cinco anos, notadamente as filantrópicas e de autogestão, integração da rede assistencial, com modelos de atenção centrados na pessoa e na autonomia médica.

10 - Paciente feminina, 25 anos, 20 semanas de gestação, deu entrada no HCM, com quadro de hemorragia vaginal, em pré-choque. Relata a acompanhante que o sangramento tinha começado há aproximadamente um dia. Foi diagnosticado deslocamento prematuro de placenta. Em que pese todas as medidas tomadas a gestante veio a falecer, após apresentar parada cardiorrespiratória, sem sucesso na reanimação. A criança nasceu morta pesando 500 gramas e medindo 25 centímetros. Como deveria ser preenchido a declaração de óbito da mãe e qual a conduta ética e legal em relação ao óbito fetal:

A) Causa Terminal ou Imediata (linha a): Parada cardiorrespiratória; Causa Intermediária (linha b): Choque Hipovolêmico; Causa Intermediária (linha c): Aborto e Causa Básica (linha d): Deslocamento Prematuro de Placenta. Como se trata de um óbito fetal com menos de 28 semanas, com o feto pesando 500 gramas e medindo 25 centímetros, não se deve preencher a declaração de óbito, pois trata-se de aborto.

B) Causa Terminal ou Imediata: Choque Hipovolêmico; Causa Básica: Deslocamento Prematuro de Placenta e na parte II gestação de 20 semanas. Deverá ser preenchida obrigatoriamente a declaração de óbito e no campo I do Bloco I, que se trata de um óbito fetal e, no campo relativo à identificação – nome – deve ser colocado morte fetal.

C) Causa Terminal ou Imediata: Choque Hipovolêmico; Causa Básica: Deslocamento Prematuro de Placenta. Como se trata de um óbito fetal com 20 semanas, com o feto pesando 500 gramas e medindo 25 centímetros, deve ser encaminhada a família ao cartório para registrar a criança e, após a realização deste procedimento, preencher a declaração de óbito.

D) Causa Terminal ou Imediata (linha a): Parada cardiorrespiratória (linha a); Causa Intermediária (linha b): Choque Hipovolêmico; Causa Intermediária (linha c): Aborto e Causa Básica (linha d): Deslocamento Prematuro de Placenta. Como se trata de um óbito fetal com menos de 28 semanas, com o feto pesando 500 gramas e medindo 25 centímetros, não se deve preencher a declaração de óbito, pois trata-se de aborto.

11 - Foi realizado um Estudo de Intervenção, com o objetivo de se verificar o efeito da Trombólise IV em paciente com supra desnivelamento de ST ou Bloqueio de Ramo e Delta. Tempo de até seis horas do início de sintomas do Infarto Agudo do Miocárdio. Os dados do estudo estão na Tabela abaixo. Os números foram arredondados para facilitar o cálculo:

Grupos			
	Morte	Cura	TOTAL
Tratado	1.300	11.700	13.000
Controle	1.700	11.300	13.000

Baseado na Tabela, calcule a Estimativa do Tamanho do Efeito do Tratamento (Número necessário de pacientes necessários para que o tratamento tenha um efeito positivo):

- A) 1,3.
- B) 3.
- C) 33.
- D) 400.

12 - Paciente masculino, pintor e trabalha em uma metalúrgica onde opera instrumento de pintura a revolver. Segundo o PPRA da empresa, neste setor os trabalhadores estão expostos ao chumbo inorgânico, ruído acima de 85 dB, tolueno e metil-etil-cetona. Como médico do trabalho da empresa, quais exames complementares você solicitaria no exame periódico deste trabalhador, de acordo com o Quadro I da NR-7?

A) Plumbemia, ácido delta amino levulínico, audiometria, ácido hipúrico e metil-etil acetona urinária.

- B) Fenol urinário, metemoglobina, dosagem de chumbo no sangue, zinco protoporfirina, audiometria, dosagem de tolueno no sangue e metil-etil-acetona sanguínea.
- C) Fenol urinário, metanol urinário, dosagem de ácido hipúrico no sangue, zinco protoporfirina, audiometria, fenol urinário, hemograma, protoparasitológico, urina I e hemograma.
- D) Raio-X de osso longos para detectar imagens de impregnação pelo chumbo, raio-X de pulmão para avaliar saturnismo, dosagem de chumbo no sangue, audiometria, fenol urinário, urina I, hemograma e metil-etil-acetona urinária e sanguínea.

13 - Em uma reunião com 200 participantes, no Hotel "Come-se Bem e à Vontade", promovida pela Secretaria de Saúde para um curso de atualização em Tuberculose; levou-se inicialmente 50 profissionais para uma Unidade de Saúde próxima, com quadro de náuseas, vômitos, diarreia e cólicas abdominais. A investigação de surto identificou um total de 120 casos, envolvendo o consumo de sanduíche de presunto e queijo, oferecido durante o lanche vespertino do segundo dia da reunião e confirmou sua etiologia estafilocócica. Qual a Taxa de Ataque Inicial e final do surto, respectivamente:

- A) 0,25 e 0,6.
- B) 0,5 e 1,2.
- C) 5 e 12.
- D) 50 e 120.

14 - Menino, 6 anos, foi "picado por um bicho", não soube qual. Seus pais ficaram apavorados, pois outras crianças foram picadas por escorpião ali no bairro e uma das crianças com 5 anos morreu. Levaram o filho assintomático para a UPA. O paciente passou pelo acolhimento e classificação de risco com uma enfermeira, sendo classificado em azul (prioridade 3 – consultas de baixa complexidade – atendimento de acordo com o horário de chegada) podendo ser o atendimento até em 1 hora. Após 50 min, a criança referiu dor forte no local da picada, muita sudorese e os pais observaram vermelhidão e inchaço no local. Esta evolução reforçou a possibilidade de um acidente por picada de escorpião, e assim chamaram a enfermeira. A enfermeira avaliou imediatamente, sendo que o paciente foi reclassificado em vermelho (prioridade zero - emergência, necessidade de atendimento imediato), pois pode ter evolução muito grave e óbito. Foi encaminhado urgente para a Emergência do HE (Hospital de Ensino) que é referência para a aplicação de soro antiescorpiônico. Em relação a este caso pode-se afirmar que:

- A) Acolhimento com Classificação de Risco é uma ferramenta com objetivo encaminhar a maioria dos casos e organizar o atendimento de todos, evitando filas.
- B) Acolhimento com Classificação de Risco é atividade realizada por profissional de nível superior da enfermagem, da medicina e da psicologia, preferencialmente com experiência em serviço de urgência, e após capacitação específica para a atividade proposta.
- C) Acolhimento com Classificação de Risco configura-se, como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização das portas de urgência e na implementação do cuidado em rede, pois extrapola o espaço de gestão local.
- D) Acolhimento com Classificação de Risco é, dependendo da grande demanda, é realizado por toda a equipe que atua na urgência: enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, assistentes sociais e funcionários administrativos.

15 - Em setembro de 2021, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu uma meta global ambiciosa. A agência de saúde da ONU pediu que 70% da população global fosse vacinada até meados de 2022. Aquela altura, pouco mais de 3% das pessoas em países de baixa renda havia sido vacinadas com pelo menos uma dose, em comparação com 60-18% em países de alta renda. Seis meses depois, o mundo está longe de atingir essa meta. O número total de vacinas administradas aumentou drasticamente, mas também a desigualdade da distribuição: das 10,7 bilhões de doses distribuídas em todo o mundo, apenas 1% foi administrada em países de baixa renda. Isso significa que 2,8 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda estão esperando por sua primeira dose. A desigualdade nas vacinas põe em risco a segurança de todos e contribui para aumentar as desigualdades entre – e dentro – dos países. Esse estado de coisas não apenas corre risco de prolongar a pandemia, mas esta desigualdade, tem muitos outros impactos, retardando a recuperação econômica de países inteiros, mercados de trabalho globais, pagamentos da dívida pública e capacidade dos países de investir em outras prioridades (Nações Unidas, março 2022). Dentre os princípios do Sistema de Saúde brasileiro, relacionados abaixo, qual deles visa atenuar as desigualdades e injustiças sociais:

- A) Equidade.
- B) Universalidade.
- C) Participação social.
- D) Integralidade da atenção à saúde.

16 - Na reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) o Ministério da Saúde pela Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. O conceito de Rede de Atenção à Saúde – RAS é:

- A) Definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.
- B) Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e de mesmo tamanho, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) É composta de pontos de atenção à saúde entendidos como espaços onde se ofertam determinados serviços de saúde, independente da hierarquização dos serviços e da regionalização.
- D) Estabeleceu o espaço regional como locus privilegiado, para o atendimento dos casos graves, com a construção das responsabilidades pactuadas, uma vez que é esse espaço que permite a integração de políticas e programas por meio da ação conjunta das esferas federal, estadual e municipal.

17 - Médico, 25 anos, está na 1ª semana de atividade da residência de cirurgia em um Hospital de Ensino (HE), referência regional para atendimentos secundários e terciários. O residente acidenta-se, ao fazer um procedimento, com material perfuro cortante contaminado com sangue do paciente que está sob os cuidados da equipe cirúrgica, na qual ele está passando. Este paciente com AG HBS positivo faz tratamento para Hepatite B no HE. O residente ainda não foi vacinado contra Hepatite B, embora esteja agendado na sala de vacina para atualizar a sua situação vacinal. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, para acidentes ocupacionais com material perfuro

contaminados, além do atendimento na emergência para o ferimento, qual a conduta na emergência do Hospital em relação a prevenção da Hepatite B?

- A) Deve ser administrada nas primeiras horas após o acidente a imunoglobulina humana anti-hepatite B, sendo 0,06/kg IM. Iniciar o esquema de vacinação para Hepatite B com a primeira dose e agendar as próximas duas doses. Notificação compulsória do acidente.
- B) O profissional que recebeu após o acidente a imunoglobulina humana anti-hepatite B não devem receber esta vacina no momento do acidente, pois deve aguardar três meses para iniciar a vacinação. Notificação compulsória do acidente.
- C) Tem indicação apenas de imunoglobulina humana anti-hepatite, porém não está disponível pelo Sistema Único de Saúde o hospital deve providenciar a compra o mais urgente possível. Notificação compulsória do acidente.
- D) Pode ser administrada a primeira dose da vacina contra hepatite B e agendar as próximas duas doses. Fazer a imunoglobulina humana anti-hepatite B (0,06/kg IM) após avaliar se há presença de marcadores de replicação viral no paciente fonte. Notificação compulsória do acidente.

18 - Homem de 21 anos, procura atendimento na Emergência do HE com história de há 3 dias apresentar febre, mialgia, fadiga, cefaleia, astenia, dor nas costas, linfadenopatia e lesões no abdome inicialmente puntiforme avermelhada que evoluiu para vesículas. Relata que teve contato sexual com o seu companheiro há 10 dias, sendo que este apresentava quadro e lesões semelhantes. Na investigação do paciente foram solicitados exames para monkeypox (MPX), varicela, herpes zoster, sarampo, zika, dengue, chikungunya, herpes simples, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo e granuloma inguinal. O caso suspeito de MPX é uma das doenças de notificação compulsória, em todo território nacional, conforme Portaria GM/MS nº 3.418, de 31 de agosto de 2022. Das alternativas abaixo qual é a correta em relação a suspeita de MPX?

- A) A MPX é uma doença zoológica viral. A transmissão é rara entre humanos ocorre por meio de contato próximo/íntimo com lesões na fase de vesícula com a pele de pessoas infectadas. Não é observada a transmissão por secreções respiratórias.
- B) Caso suspeito: Indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março de 2022, apresente início súbito de erupção cutânea aguda sugestiva de MPX, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital), associada ou não a febre, adenomegalia, astenia, dor nas costas e cefaleia.
- C) Definição de contato: pessoa que esteve presente em um grande evento onde foram relatados muitos casos de MPX, independente de contato com caso provável ou confirmado.
- D) O caso confirmado de MPX deverá se manter em isolamento durante o período febril e a erupção cutânea apresenta a vesícula, pois é transmissível neste período. As lesões na fase crostas persistem por 2 semanas não sendo transmissível.

19 - Homem, 20 anos, em união estável há 12 meses com mulher com 18 anos. Paciente em atendimento na UBS relata que estava assintomático. Foi convocado para ir a UBS, pois a sua companheira está pretendendo engravidar e foi identificado que entre os exames solicitados para ela a sorologia para sífilis (VDRL) é positiva. Informa que está sendo tratada para sífilis e foi notificada. Ele refere que, antes de conhecer a companheira atual, teve múltiplas parceiras sexuais.

Foi solicitado que ele fizesse todos os exames. Embora assintomático a sorologia para sífilis (VDRL) dele é positiva. Qual a conduta?

- A) Tratamento com benzilpenicilina Benzatina 2,4 milhões UI, intramuscular, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo), marcar retornar para repetir exame e ser orientado sobre o uso regular de preservativo. Notificação compulsória da sífilis.
- B) Tratamento com rifampicina 300 mg de 12 em 12h por 1 semana, retornar para repetir exame após 1 semana. Notificação compulsória imediata.
- C) Tratamento com penicilina procaína 2.400.000 unidades (1,2 milhão UI em cada glúteo), por dia durante 3 dias, retornar para repetir exame e ser orientado uso regular de preservativo. Notificação compulsória da sífilis.
- D) Tratamento com rifampicina 300 mg de 12 em 12h por 15 dias, retornar para repetir exame após 2 semanas. Notificação compulsória da sífilis.

20 - Adolescente feminina, 16 anos, saudável, estudante de ensino médio, procura atendimento na Unidade Básica de Saúde, sem acompanhante. Refere que já iniciou a vida sexual e gostaria de fazer uso da pílula anticoncepcional, apesar de utilizar preservativo. O médico que atende diz que só pode prescrever o método pedido após falar com um de seus pais ou responsável legal. Em relação a conduta do médico aponte a alternativa correta:

- A) A conduta do médico foi adequada com a adolescente, pois é menor de idade, portanto, legalmente incapaz. É importante que seus pais ou o responsável legal saibam que ela tem vida sexual. Com anuência deles a pílula pode ser prescrita.
- B) A conduta do médico não foi adequada com a adolescente, pois poderia prescrever a pílula anticoncepcional, desde que reforçasse a necessidade de continuar usando o preservativo e convocasse os pais ou responsável legal para deixá-los cientes da situação.
- C) A conduta do médico não foi adequada com a adolescente, pois mesmo sendo menor de idade, a paciente mostra-se capaz de tomar decisões relativas a sua saúde e não há necessidade de comunicar aos responsáveis legais assuntos de sua vida sexual.
- D) A conduta do médico foi adequada com a adolescente, pois ele deve exigir a presença dos pais ou do responsável, porque a pílula anticoncepcional está contraindicada para adolescente, pelo risco de abandono do uso do preservativo.

21 - Homem 54 anos, lavrador, residente na área de abrangência Unidade Básica de Saúde a (UBS) com Estratégia de Medicina Família do município X, apresenta perda de peso acentuada nos últimos três meses. Teve diagnóstico de câncer de estômago, no início do quadro, e foi submetido à cirurgia e sessões de radioterapia, que foram suspensas há um mês após constatação de metástases em vários órgãos. O paciente evoluiu para um quadro de caquexia e vinha recebendo tratamento sob regime domiciliar, pelo médico da Equipe de Saúde da Família desta UBS, que o visita regularmente em casa. A família procura este médico na UBS e comunica que, após a última visita, o paciente evoluiu com falta de ar, vindo a falecer no domicílio:

- A) O médico da família não emitirá a DO, considerando-se que embora ele prestasse assistência médica ao falecido, conhecia o quadro clínico apresentado nos últimos meses, bem como o prognóstico do quadro, o óbito foi no domicílio sem assistência médica.

D) O médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), do Programa de Internação Domiciliar e outros assemelhados, deverá verificar pessoalmente o cadáver, após ter sido comunicado do óbito e emitirá a DO, considerando-se que prestava assistência médica ao paciente, conhece o quadro clínico, bem como o seu prognóstico.

22 - Mulher, 50 anos, com peso de 110 kg e altura de 1,60, sendo seu IMC = 43 kg/m², com diagnóstico de sobrepeso grau III. Foi submetido a cirurgia redutora de estômago e recebeu alta hospitalar. Retornou no 4º dia do pós-operatório, quando foi diagnosticado fístula da anastomose esôfago gástrica. Realizada cirurgia com sutura da fístula, porém evoluiu com peritonite e septicemia, falecendo 11 dias depois no hospital onde estava internado:

OBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL ☒ A morte ocorreu ☐ Em gravidez ☐ Em parto ☐ Em puerpério ☐ Em 42 dias após o parto ☐ De 43 dias a 1 ano após o parto ☐ Ignorado		ASSISTÊNCIA MÉDICA ☒ Recebeu assistência médica durante o dia que precedeu a morte? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado		DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR ☒ Neuropsiquiatra? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado	
CAUSAS DA MORTE PARTE I Descreva os fatores mortais que causaram o óbito e a morte. CAUSAS ANTERIORES Descreva doenças, se existentes, que produziram o óbito, antes, durante, imediatamente em último lugar o último óbito.		ANTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA a) <u>Pneumonia</u> b) <u>Excesso de consumo de álcool</u> c) <u>Excesso de consumo de drogas</u> d) <u>Excesso de consumo de drogas</u> e) <u>Excesso de consumo de drogas</u> f) <u>Excesso de consumo de drogas</u> g) <u>Excesso de consumo de drogas</u>		Tempo decorrido entre o óbito e a morte ☐ ☐	
PARTE II Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não estiveram, porém, na causa direta.					

D) Parte I. Sobrepeso grau III; Cirurgia p/ redução do estomago; Fistula gástrica; Peritonite; Parte II. Hipercolesterolemia.

23 - Criança de 3 anos e 6 meses da entrada na emergência pediátrica com quadro de insuficiência respiratória. Mãe relata que apresenta tosse seca e coriza há 1 semana, acompanhada de febre que chegou aos 39° nos últimos dias. Há 2 dias percebe estridor quando criança fica mais irritada, sendo que na admissão hospitalar o estridor está intenso. Criança rapidamente evolui para colapso circulatório com necessidade de intubação e transferência para UTI. Durante intubação notou-se faringe com secreção purulenta e necessidade de cânula orotraqueal menor que a calculada para idade. Qual das alternativas mostra a principal hipótese diagnóstica?

- A) Supraglotite.
- B) Crupe viral.
- C) Traqueíte bacteriana.
- D) Crupe espasmódico.

24 - Criança de 1 ano e 6 meses interna na enfermaria de pediatria para tratamento de pneumonia, ao verificar seus dados antropométricos nota-se que apresenta peso para estatura maior que o escore Z+1 e menor que escore Z+2. O peso para idade se localiza no mesmo escore (maior que o escore Z+1 e menor que escore Z+2). Podemos afirmar que este paciente apresenta:

- A) Eutrofia.
- B) Obesidade.
- C) Sobrepeso.
- D) Risco de sobrepeso.

25 - Criança é levada para atendimento de puericultura no dia de seu aniversário de um ano, é um menino que nasceu a termo com peso 3.300 g e comprimento 50 cm. Nesta consulta, com um ano de vida, foi observado que apresentou crescimento exatamente conforme o esperado para idade, considerando isto, quais medidas antropométricas seriam as mais adequadas para esta criança?

- A) Peso 7,5 kg, estatura 65 cm.
- B) Peso 10,5 kg, estatura 75 cm.
- C) Peso 12,5 kg, estatura 80 cm.
- D) Peso 14 kg, estatura 90 cm.

26 - Menino de 10 anos é levado no pediatra para avaliação de rotina, no exame físico nota se que o escroto se apresenta levemente aumentado, com pele mais escura e mudança de textura. Pênis sem aumento. Observa-se também pelos finos, longos e curvos, esparsos, mas com maior concentração próximo à base do pênis. O pediatra poderá registrar que o estágio puberal do genital (G) e dos pelos púbicos (P) da criança são respectivamente:

- A) G1 P1.
- B) G1 P2.
- C) G2 P1.
- D) G2 P2.

27 - Paciente com 4 anos de vida vem ao hospital, com história de febre há 5 dias, mal estar, coriza, conjuntivite, tosse e inapetência. Ao exame clínico, verifica-se criança prostrada, conjuntiva hiperemiada com secreção ocular. Ao exame da cavidade oral, nota se enantema na porção lateral aos málares, apresentando-se com pequenas manchas de coloração vermelho-vivo, no centro das quais se vê um diminuto ponto branco-azulado. Também apresenta exantema maculopapular confluyente que, segundo a mãe, iniciou na região retro auricular, se espalhando para tronco e, depois, membros. Com relação à esta doença, é correto afirmar:

- A) O uso de gamaglobulina não está indicado para contactuantes.
- B) A vacina para prevenção deve ser dada ao 2º, 4º e 6º mês de vida.
- C) A cobertura vacinal para a proteção populacional deve ser igual ou maior que 95%.
- D) O uso de vacina para os contactuantes não imunes, mesmo que precocemente, não previne a doença.

28 - Com relação à amigdalite bacteriana, é correto afirmar:

- A) O tratamento preferencial é com antibióticos beta-lactâmicos.
- B) Ocorre com mais frequência em crianças de 1 a 3 anos de idade.
- C) O período de incubação para febre reumática pós-amigdalite é entre 4 a 5 semanas.
- D) O *Streptococcus* β -hemolítico do grupo B e o *Staphylococcus aureus* são os principais agentes etiológicos.

29 - Adolescente de 13 anos chega ao consultório para uma consulta de rotina. Sua mãe relata que ele parece muito mais imaturo e inseguro do que seu filho mais velho quando na mesma idade. Seu rendimento escolar está abaixo da média. No exame físico ele está no percentil 95 de altura para a idade, suas extremidades são mais longas do que o esperado e ele mostra-se constrangido por causa da ginecomastia. Está em estágio 1 do desenvolvimento sexual de Tanner e apresenta gônadas pequenas. O diagnóstico mais provável é:

- A) Acromegalia.
- B) Síndrome XO.
- C) Síndrome XXY.
- D) Síndrome XYY.

30 - Criança com 15 meses de idade está brincando na sala de espera do ambulatório. Apresenta cianose discreta ao redor da boca e com frequência fica em posição de cócoras, quando corre fica subitamente dispneica e cianótica e então ela retorna à posição de cócoras e logo volta a respirar confortavelmente com apenas uma sutil cianose perioral. Qual das opções a seguir representa o aspecto que encontraremos no raio-X de tórax:

- A) Hiperinsuflação pulmonar.
- B) Coração em formato de bota.
- C) Coração ovoide com hilo estreito.
- D) Cardiomegalia com índice cardiorácico maior que 0,7 e congestão pulmonar.

31 - Paciente de 3 anos, pesando 18 kg é levado a unidade de pronto atendimento com história de diarreia há 05 dias associado a recusa alimentar, febre baixa e vômitos. A mãe relata que as fezes são líquidas, sem presença de muco ou sangue. Ao exame físico, a criança apresentava-se letárgica, sem filme lacrimal, olhos muito fundos, frequência cardíaca de 175 bpm, tempo de enchimento capilar de 4 segundos e sinal da prega que desaparece lentamente. Considerando o quadro acima, o diagnóstico e a conduta correta são, respectivamente:

A) Desidratação grave. O tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar. Deve-se iniciar imediatamente hidratação venosa com soro fisiológico 0,9% 20 mL/kg em 30 minutos até que ocorra melhora dos sinais de desidratação e choque e após manter hidratação venosa de manutenção com soro fisiológico 0,9% + soro glicosado 5% até que o paciente tenha condições de iniciar hidratação por via oral.

B) Desidratação grave. O tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar. Deve-se iniciar hidratação venosa de manutenção com soro fisiológico 0,9% + soro glicosado 5% com oferta hídrica de 100% holliday até que o paciente tenha condições de iniciar hidratação por via oral.

C) Desidratação moderada. O tratamento deve ser realizado na unidade de saúde com soro de reidratação oral mediante oferta de 50-100 mL/kg em 4 horas, até que os sinais de desidratação desapareçam. O paciente deverá permanecer até a reidratação completa e reinício da alimentação via oral.

D) Desidratação moderada. O tratamento deve ser realizado na unidade de saúde com soro de reidratação oral mediante oferta de 200 mL/kg em 4 horas, até que os sinais de desidratação desapareçam. O paciente deverá permanecer até a reidratação completa e reinício da alimentação via oral.

32 - Lactente de 3 meses, nascido de parto normal, pré-termo de 33 semanas e peso ao nascimento de 2.250g comparece a unidade básica de saúde para consulta de puericultura. A mãe refere que o paciente está em aleitamento materno exclusivo e que vem ganhando peso adequadamente. Visando prevenir a deficiência de ferro, qual a recomendação preconizada para esse paciente?

A) Introduzir 2 mg de Fe elementar/kg/dia a partir do 1º mês de vida até o 12º mês de vida. Após este período, reduzir a dose para 1mg de Fe elementar/kg/dia até o 24º mês de vida.

B) Introduzir 2 mg de Fe elementar/kg/dia a partir do 1º mês de vida até o 24º mês de vida e após este período, suspender a suplementação.

C) Introduzir 2 mg de Fe elementar/kg/dia a partir do 3º mês de vida até o 24º mês de vida e após este período, suspender a suplementação.

D) Introduzir 2 mg de Fe elementar/kg/dia a partir do 3º mês de vida até o 12º mês de vida. Após este período, reduzir a dose para 1mg de Fe elementar/kg/dia até o 24º mês de vida.

33 - Recém-nascido a termo, de parto vaginal com 38 semanas e Apgar 9/10, pesando 3.460 g retorna ao hospital 72 horas após a alta hospitalar apresentando crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Realizado Fenobarbital com cessação da crise. O exame físico evidenciou hepatoesplenomegalia, petéquias em membros inferiores e fundo de olho com presença de coriorretinite. Foi realizado ultrassom transfontanela com imagens compatíveis com calcificação intraparenquimatosa difusa. A principal hipótese diagnóstica é:

A) Sífilis congênita.

B) Rubéola congênita.

C) Toxoplasmose congênita.

D) Citomegalovirose congênita.

34 - Recém-nascido a termo, de parto cesárea, adequado para a idade gestacional, apgar 9/10 foi

encaminhado a sala de procedimentos para realização do teste do coraçãozinho. Durante a realização do teste, o pediatra observou uma SaO₂ de 95% no membro superior direito e de 89% no membro inferior esquerdo. Qual a recomendação preconizada para este paciente?

- A) Repetir o teste após 1 hora. Se a saturação de oxigênio permanecer menor ou igual a 89% ou a diferença de Saturação pré-ductal e pós-ductal for maior de 4%, deve-se realizar um segundo teste após 1 hora e, permanecendo as alterações acima, deve-se considerar o teste como positivo e encaminhar o RN para avaliação cardiológica completa.
- B) Repetir o teste após 1 hora. Se a saturação de oxigênio permanecer menor ou igual a 89% ou a diferença de Saturação pré-ductal e pós-ductal for maior de 4%, deve-se considerar o teste como positivo e encaminhar o RN para avaliação cardiológica completa.
- C) O teste é considerado positivo e, portanto, o RN deve ser encaminhado para avaliação cardiológica completa e não dar alta até esclarecimento diagnóstico.
- D) O teste é considerado negativo e, portanto, o RN deve ser encaminhado para seguimento neonatal de rotina.

35 - Lactente de 8 meses de idade, do sexo masculino é internado para tratamento de infecção urinária, sendo esse o primeiro episódio de infecção urinária. O médico que prestou o primeiro atendimento optou por internação hospitalar pois criança apresentava critérios de sepse. Com 48 horas de internação paciente já estava afebril e com melhora clínica, apresentando sinais vitais adequados para idade. A urocultura veio positiva para *Klebsiella pneumoniae* sensível a todos os antibióticos testados. Neste caso qual a conduta mais apropriada:

- A) Realizar Us de rins e vias urinária ainda durante a fase aguda de infecção e descalonar antibiótico para via oral.
- B) Descalonar antibiótico para via oral e realizar Us de rins e vias urinária ambulatorial de caráter não urgente.
- C) Manter tratamento completo com antibiótico de escolha inicial, já que paciente foi admitido com septicemia e apresentou melhora clínica e realizar Us de rins e vias urinária ainda durante internação.
- D) Terminar tratamento com o Antibiótico de escolha inicial por boa resposta clínica e por ser primeiro episódio de ITU não apresenta indicação de realização de Us de rins e vias urinárias.

36 - Lactente de 10 meses de idade, em aleitamento materno e boa aceitação de alimentos durante a introdução alimentar passa em consulta de puericultura, sem queixas no momento da consulta. Durante a consulta a mãe refere que ele não consegue segurar pequenos objetos com movimento de pinça, fala "ma", "da" e "be", senta-se sozinho. Ao exame físico, sem alterações. Quanto ao desenvolvimento deste paciente, podemos avaliar:

- A) Desenvolvimento adequado para a idade.
- B) Atraso em todos os marcos de desenvolvimento para a idade.
- C) Alerta no desenvolvimento motor fino, atraso no desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor grosseiro adequado.
- D) Atraso no desenvolvimento motor fino, atraso no desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento motor grosseiro adequado.

37 - Recém-nascido (Rn) termo de parto cesárea por complicação materna (Descolamento prematuro de placenta), peso de nascimento de 3420g e APGAR 8/9. Mãe tem 36 anos G1P0A0, pré-natal sem outras intercorrências. O Rn está agora com 12 horas de vida e a mãe se queixa de baixa produção de leite materno. Ao exame físico, sem alterações. A melhor conduta frente a esse caso será:

- A) Iniciar domperidona para a mãe.
- B) Orientar pega e aguardar apojadura.
- C) Iniciar translactação com fórmula infantil.
- D) Iniciar complementação com fórmula infantil em copinho.

38 - Paciente de 46 anos de idade, obesa, hipertensa crônica e tabagista, encontra-se na 10ª semana de gestação. Retorna para sua segunda consulta de pré-natal na Unidade Básica de Saúde e, ao serem avaliados os resultados dos exames solicitados, foi observado glicemia de jejum = 90 mg/dL. Neste caso, qual é a conduta adequada:

- A) Realizar Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) de 75 g entre 24 e 28 semanas de gestação.
- B) Solicitar nova glicemia de jejum e hemoglobina glicada entre 16 e 18 semanas de gestação.
- C) Repetir glicemia de jejum e, se manter o valor, iniciar hipoglicemiante por via oral, pois é um diagnóstico de diabetes gestacional.
- D) Manter rotina normal de consultas e solicitar nova glicemia de jejum na 24ª - 26ª e 34ª semana de gestação.

39 - Primigesta na 14ª semana de gestação com VDRL 1:8, assintomática, sem tratamento anterior para sífilis, comparece para a sua segunda consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde. Ao receber a receita, refere que é alérgica à penicilina. Nesses casos, a conduta adequada a ser realizada é:

- A) Realizar dessensibilização e tratar com Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de UI/ IM por semana, durante 3 semanas, com controle quantitativo com teste não treponêmico mensal até o nascimento.
- B) Considerar paciente portadora de sífilis primária. Realizar dessensibilização e tratar com Penicilina G Benzatina, 2,4 milhões de UI/ IM, com controle quantitativo com teste treponêmico trimestral até o final da gravidez.
- C) O tratamento diante nessas situações é eficaz para não ocorrer transmissão vertical com o uso de Ceftriaxona IV, uma vez ao dia, durante 14 dias.
- D) No momento não tratar, solicitar testes treponêmicos e não treponêmicos para afastar a possibilidade de cicatriz sorológica.

40 - Gestante de risco habitual, na 31ª semana, comparece para atendimento de emergência relatando perda de líquido por via vaginal há 4 horas. Exame físico geral sem alterações. Ao exame obstétrico, apresenta altura uterina de 29 cm, batimento cardíaco fetal: 148 bpm, dinâmica uterina ausente e exame especular: colo entreaberto, com saída de líquido pelo canal cervical. De acordo com esses dados, é correto realizar a seguinte conduta:

- A) Internação, repouso absoluto, inibição profilática do trabalho de parto prematuro e neuroproteção fetal.
- B) Aguardar resultado do exame ultrassonográfico para confirmar a hipótese de bolsa rota, depois iniciar as condutas.
- C) Internação, preparo do colo e indução imediata do parto por via vaginal devido a possibilidade de corioamnionite e hipoplasia pulmonar.
- D) Internação, repouso relativo, aceleração da maturidade pulmonar fetal com corticoide e antibioticoprofilaxia para Streptococcus do grupo B.

41 - Uma gestante, em sua consulta de pré-natal em Unidade Básica de Saúde, está preocupada porque seu filho ainda não nasceu. De acordo com a data da última menstruação, está no momento da consulta com 42 semanas de gestação, que coincide com exame ultrassonográfico realizado na 8ª semana de gestação. Ao exame físico e obstétrico, apresenta: pressão arterial = 100x60 mmHg, altura uterina = 38 cm, frequência cardíaca fetal = 140 bpm, sem desacelerações, colo apagado 50%, fechado, feto único, cefálico e insinuado. De acordo com esses dados, qual é a conduta adequada:

- A) Orientar a gestante e encaminhar para a maternidade para avaliação da vitalidade fetal, preparo do colo e indução do parto.
- B) Internação, cardiotocografia, dopplervelocimetria de ducto venoso e perfil biofísico diários e, se alterados, realizar operação cesariana.
- C) Encaminhar a gestante para a maternidade de alto risco para realizar cesariana devido desproporção cefalopélvica e índice de Bishop desfavorável para indução de parto via vaginal.
- D) Tranquilizar a gestante e orientar para procurar a maternidade caso apresente perda de líquido e se constatar quantidade inferior a 6 movimentos fetais em duas horas de observação.

42 - Durante a condução de um trabalho de parto em uma gestante hipertensa, ao ser realizado exame cardiotocográfico, foram observadas Desacelerações Intraparto (DIP) do tipo II ou tardios. Esta alteração está relacionada a:

- A) Insuficiência placentária e hipóxia fetal.
- B) Desacelerações decorrentes de compressão funicular.
- C) Compressão do polo cefálico durante as contrações uterinas.
- D) Desacelerações variáveis devido à diminuição do líquido amniótico.

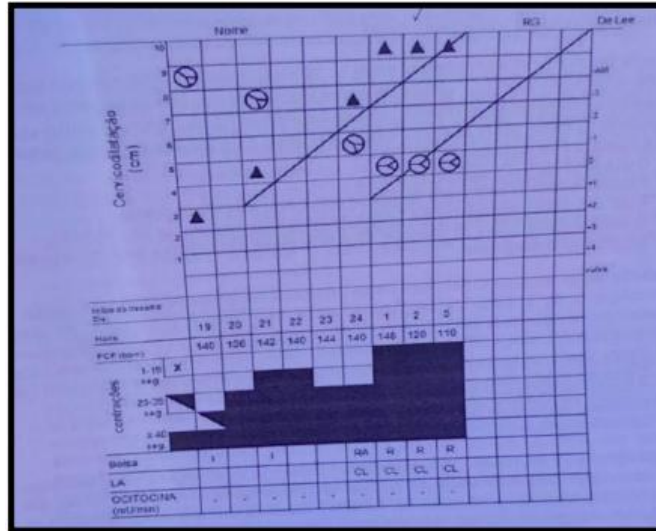
43 - Durante o exame obstétrico de uma gestante de 38 semanas, em trabalho de parto, foi observado: palpação abdominal (manobras de Leopold-Zweifel) = não evidenciado polo fetal ocupando o fundo uterino; fundo uterino pouco acima da cicatriz umbilical; batimentos cardíacos fetais = normais; dilatação cervical = 8 cm; bolsa das águas rota. De acordo com esses dados, assinale a alternativa correta:

- A) A situação fetal é transversa com apresentação córmica, cujo ponto de referência fetal é o acrômio e a conduta é operação cesariana.
- B) Trata-se de um caso de distócia do trajeto duro no estreito superior da bacia, com diâmetro diminuído da conjugata diagonalis e a conduta é posição verticalizada materna.

C) Os dados relatados acima demonstram feto em apresentação pélvica incompleta, secundária a distócia de trajeto mole e a conduta é operação cesariana.

D) Trata-se de um caso de distócia da posição fetal, com localização topográfica no estreito inferior da bacia e a conduta é a rotação para occipito púbica.

44 - Primigesta, gestação de risco usual, com a evolução do trabalho de parto demonstrada no partograma abaixo:



Assinale a alternativa que contém o tipo de distócia apresentada e a conduta obstétrica:

- A) Parada secundária da descida e fórceps de rotação.
- B) Parada secundária da descida e operação cesariana.
- C) Fase ativa protraída e infusão intravenosa de ocitocina.
- D) Desproporção cefalopélvica relativa e infusão intravenosa de ocitocina.

45 - Mulher, 32 anos de idade, G = 0, referindo Sangramento Menstrual Excessivo (SME), com desejo de gestação. Seu ultrassom transvaginal demonstrou espessamento endometrial. Foi realizada uma histerossonografia com a imagem abaixo:



Qual a melhor conduta para esta paciente?

- A) Histeroscopia cirúrgica.
- B) Progesterona em alta dose para conter o SME.
- C) Acompanhamento com ultrassom semestral e uso de anti-inflamatório no período menstrual.
- D) Utilizar um contraceptivo hormonal oral para regular sua menstruação.

46 - Mulher de 28 anos com colpocitologia oncótica com resultado de NIC-I (lesão intraepitelial cervical de baixo grau). A conduta é:

- A) Conização do colo do útero.
- B) Histerectomia abdominal total.
- C) Cauterização com laser de CO₂.
- D) Repetir colpocitologia oncótica em 6 meses.

47 - Paciente feminina de 45 anos, tabagista desde os 16 anos, procurou atendimento com queixa de hiperemia em mama direita há 1 semana. Ao exame clínico apresenta área de hiperemia em região periareolar da mama direita, associada a ponto de flutuação de 0,5 cm. Referiu já ter tido um caso semelhante na mama oposta há alguns meses. A hipótese diagnóstica foi de mastite periareolar. Qual a conduta a ser realizada?

- A) O tabagismo não tem relação com o quadro.
- B) É necessário realizar mamografia diagnóstica para avaliar extensão da doença.
- C) Tratar com antibioticoterapia por 5 a 7 dias e, se necessário, estender por 10 a 14 dias.
- D) Quando realizada cultura da secreção, 50 a 60% destas são positivas para microrganismos potencialmente patogênicos.

48 - Paciente de 30 anos. G = 1, P = 1, com desejo reprodutivo foi encaminhada ao ambulatório de ginecologia devido à queixa de sangramento vaginal intermitente e sinusorragia. Ao exame ginecológico foi evidenciada lesão vegetante friável no colo do útero de 4 cm e paramétrio esquerdo comprometido pela doença (toque retal). Os exames de imagem confirmaram o estadiamento clínico da doença. Qual o tipo histológico mais comum e o tratamento que deverá ser proposto?

- A) Carcinoma espinocelular de colo – traquelectomia.
- B) Adenocarcinoma de colo – quimioterapia exclusiva.
- C) Carcinoma espinocelular de colo – radioterapia + quimioterapia.
- D) Adenocarcinoma de colo – histerectomia radical modificada (Wertheim-Meigs).

49 - Casal com desejo de gestação, procura orientação. Ela com 33 anos, nuligesta, ciclos menstruais regulares. Nega cirurgias anteriores. Histerossalpingografia normal. Ultrassom pélvico normal. Ele com 33 anos, nega uso de medicamentos. Fumante. Espermograma: volume: 2,5 mL, número de espermatozoides por mL: 500.000, Vitalidade: 60% Qual tratamento a ser oferecido?

- A) FIV (fertilização in vitro).
- B) Vídeo laparoscopia diagnóstica.

- C) ICSI (inseminação intracitoplasmática de espermatozoides).
- D) Indução de ovulação seguida de IIU (inseminação intrauterina).

50 - Mulher, 27 anos, procura ambulatório de planejamento familiar com desejo de utilizar método contraceptivo. Atualmente encontra-se sem comorbidades, mas apresenta história de trombose venosa profunda há vários anos. Qual método contraceptivo abaixo pode ser utilizado por essa paciente?

- A) Anel vaginal.
- B) Adesivo transdérmico.
- C) Contraceptivo hormonal oral.
- D) Progestagênios orais isolados.

51 - Mulher, 30 anos, usuária de DIU de cobre há um ano, teve confirmada gestação de 12 semanas, sem localização do fio. A conduta médica correta é:

- A) Interromper a gestação.
- B) Deixar a gestação evoluir.
- C) Retirar o DIU instrumentalmente.
- D) Retirar o DIU e usar antibiótico profilático por 7 dias.

52 - Um paciente será submetido a apendicectomia devido a apendicite aguda não complicada. Quanto ao planejamento do uso de antibióticos para este paciente, assinale a alternativa correta:

- A) Ceftriaxona 2 g uma vez ao dia, por cinco dias.
- B) Cefazolina 1 g a cada oito horas nas primeiras 24 horas.
- C) Cefazolina 1 g em dose única até uma hora antes do início da cirurgia.
- D) Ceftriaxona 2 g uma vez ao dia e metronidazol 500 mg a cada oito horas por sete dias.

53 - Mulher de 42 anos é encaminhada para o hospital com quadro de dor em andar superior do abdome, irradiada para o dorso associada a um episódio de vômito bilioso há 24 horas. Ela refere que está na fila para realização de colecistectomia devido a colelitíase sintomática. Ao exame físico ela se encontra consciente e orientada, desidratada, e com mucosas ictéricas. Os sinais vitais são: pulso de 110 bpm, frequência respiratória de 22 ipm, pressão arterial de 90x40 mmHg, temperatura de 36,2°C e saturação de O₂ de 88. O exame cardiorrespiratório mostra taquicardia e murmúrio vesicular abolido em base pulmonar esquerda. Seu abdome está distendido, com ruídos abdominais diminuídos, timpânico, com dor a palpação, mas sem dor a descompressão brusca e o toque retal não apresenta alterações. O médico plantonista suspeita de pancreatite aguda. Para confirmação diagnóstica o próximo passo é:

- A) Solicitar colangiorressonância.
- B) Solicitar radiografia do abdome.
- C) Solicitar tomografia de abdome.
- D) Dosagem das enzimas pancreáticas.

54 - Mulher de 37 anos é encaminhada ao setor de pronto atendimento do hospital com queixa de dor em abdome superior em faixa irradiada para o dorso e associada a distensão abdominal e náuseas há 2 dias. No exame físico, ela apresenta-se desidratada, levemente dispneica e ansiosa. O exame cardiopulmonar não apresenta anormalidades e no exame abdominal ela apresenta distensão abdominal, ruídos hidroaéreos presentes e dor a palpação do andar superior, mas sem dor a descompressão brusca. São solicitados exames laboratoriais que mostram hematócrito de 36%; hemoglobina de 11,6 mg/dL; leucócitos de 12.000 mm³; amilase de 1280 U/L; lipase de 530 U/L. Uma ultrassonografia de abdome é solicitada e revela cálculos no interior da vesícula biliar, mas sem sinais de colicistite aguda. Assinale a alternativa que contém as prioridades na condução deste caso:

- A) Reposição hídrica, controle da dor e alimentação oral precoce.
- B) Bloqueio da acidez gástrica, antibioticoterapia e nutrição parenteral.
- C) Anticoagulação, antibioticoterapia e descompressão gástrica por sonda.
- D) Drogas pró cinéticas, transfusão de hemoderivados e nutrição parenteral.

55 - Um paciente com quadro de obstrução intestinal por intussuscepção é submetido a laparotomia exploradora e após a redução da invaginação é encontrado a afecção mostrada na foto abaixo:



Sobre esta afecção podemos afirmar que se trata de:

- A) Divertículo epifrênico.
- B) Divertículo de Meckel.
- C) Divertículo de Zenker.
- D) Pseudo-divertículo intestinal.

56 - Mulher de 65 anos, é encaminhada para a emergência do hospital com quadro de hemorragia digestiva. Ela não apresenta comorbidades. Após ressuscitação hídrica e monitorização hemodinâmica, a paciente se mantém estável e a dosagem de hemoglobina sérica da paciente é de 10,5 mg/dL. Em seguida é realizada uma endoscopia digestiva alta que mostra uma úlcera

duodenal de 0,8 cm com sangramento ativo. O endoscopista realiza hemostasia com uso de hemoclipes e adrenalina e relata que obteve sucesso com a hemostasia. Assinale a alternativa correta sobre a conduta a seguir para a paciente:

- A) Alta com omeprazol 40 mg via oral de 12/12 horas por quatro semanas.
- B) Observação em UTI com dosagem seriada da hemoglobina e IBP endovenoso.
- C) Arteriografia e embolização da artéria gastroduodenal e observação em UTI.
- D) Cirurgia com realização de vagotomia e piloroplastia e pós-operatório em enfermaria.

57 - Para evitar a ocorrência de inguinodinia, durante a realização de uma herniorrafia pelo reparo anterior, o cirurgião deve evitar a transecção ou retenção de quais nervos?

- A) Peniano, inguinal e femoral.
- B) Frênico, femoral e pudendo interno.
- C) Genitofemoral, cutâneo lateral e ciático.
- D) Ileoinguinal; ileohipogástrico e ramo genital do genitofemoral.

58 - Paciente de 70 anos, relata que vêm apresentando dificuldade para engolir há vários anos, queixando-se de sensação de entalo até para alimentos pastosos necessitando de ingesta de líquido para "empurrar" a comida. Notou emagrecimento neste período, acha que perdeu 20 Kg. Nasceu e reside em zona rural próximo a São José do Rio Preto, nega histórico de neoplasia em sua família. Procurou atendimento em sua cidade onde realizou uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA) cujo laudo mostrou esofagite edematosa e gastrite enantematosas. Sobre este quadro clínico e dentre as alternativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na condução deste caso:

- A) Solicitar um Exame Radiológico Contrastado tendo como hipótese diagnóstica o megaesôfago.
- B) A EDA foi sugestiva de refluxo gastroesofágico, com isso iniciar o tratamento com Inibidor de Bomba de Próton (IBP) e medidas comportamentais.
- C) O melhor seria repetir a EDA com biópsias para pesquisa do *Helicobacter Pylori*.
- D) Iniciar tratamento com IBP mas solicitar uma tomografia de tórax para excluir uma compressão extrínseca.

59 - Paciente de 30 anos realizou uma tomografia de abdômen para avaliação de calciose renal. Todavia, o exame revelou uma massa sólida de 2,5 x 2,0 x 2,2 cm de tamanho em adrenal esquerda de natureza indeterminada. Qual das doenças abaixo é a causa mais comum de uma massa suprarrenal unilateral?

- A) Feocromocitoma.
- B) Carcinoma adrenocortical.
- C) Adenoma adrenocortical não-funcionante.
- D) Adenoma adrenocortical produtor de cortisol.

60 - Uma mulher de 45 anos apresenta um nódulo indolor de 3 cm na região anterior direita do pescoço que surgiu há 3 meses e lentamente está aumentando. No exame físico a massa é firme e move-se para cima e para baixo com a deglutição. Nega perda ou ganho de peso, intolerância

ao calor ou ansiedade. A dosagem do TSH é normal. Qual a conduta na investigação diagnóstica da paciente?

- A) Cintilografia com ^{131}I .
- B) Ressonância magnética do pescoço.
- C) Tomografia computadorizada do pescoço.
- D) Punção Aspirativa com Agulha Fina (PAAF).

61 - Um jovem, vítima de acidente de moto em alta velocidade, foi atendido por uma equipe médica do pré-hospitalar e encaminhada a um Hospital Terciário, referência em Trauma. Na chegada, imobilizado com colar cervical e prancha rígida, apresenta:

- A. Via aérea com tubo endotraqueal número 8, saturando 94%;
- B. Murmúrio vesicular presente bilateral, sem ruídos adventícios;
- C. Pressão Arterial Sistólica de 86 mmHg, Frequência Cardíaca de 138 bpm. Palidez cutâneo-mucosa, FAST positivo em espaço espleno-renal e, quadril estável;
- D. Glasgow 8, com pupilas anisocóricas, midriática a esquerda.

Durante o transporte pré-hospitalar, foi medicado com um litro de Ringer Lactato em veia periférica e sedação. Neste momento, a melhor conduta seria:

- A) Iniciar Protocolo de Hipotensão Permissível para evitar aumento da Pressão Intracraniana (PIC).
- B) Ativar Protocolo de Transfusão Maciça por apresentar ABC Score de 2 pontos e Shock Index de 1,4.
- C) Ativar o Protocolo de Transfusão Maciça por apresentar ABC Score de 3 pontos e Shock Index de 1,6.
- D) Iniciar Protocolo de Hipotensão Permissível para evitar um aumento do sangramento abdominal.

62 - Um senhor de 62 anos, vítima de queda da própria altura apresenta fratura do terceiro e quarto arco costal, com hemo-pneumotórax a direita. Está no quinto dia de internação com drenagem torácica e mantém a queixa de dor em arcos costais, principalmente durante a inspiração. Nas últimas 24 horas de internação, o débito do dreno foi de 65 mL e não há mais escape de ar no frasco. A conduta mais adequada seria:

- A) Indicar videotoracosopia para limpeza da cavidade torácica.
- B) Retirar o dreno torácico e realizar radiografia torácica de controle.
- C) Manter o dreno torácico e iniciar aspiração contínua do selo d'água.
- D) Realizar nova drenagem torácica guiada com tomografia computadorizada.

63 - Um homem de 32 anos, vítima de queda de andaime há vinte minutos, vem encaminhado ao Hospital de Trauma. Encontra-se hemodinamicamente normal, saturando 94% com máscara de oxigênio e Glasgow 15. A pelve é estável, porém, apresenta dor a palpação abdominal difusa, com peritonite difusa. Foi realizada tomografia computadorizada de corpo inteiro e, o achado foi líquido livre na cavidade abdominal em moderada quantidade e lesão hepática em segmento V, VI e VII, com "blush" (Lesão Grau IV - AAST). A conduta mais adequada neste momento seria:

- A) Realizar arteriografia e embolização hepática e, em seguida, laparotomia exploradora.

- B) Indicar laparotomia exploradora, cirurgia de controle de danos e solicitar vaga em Unidade Terapia Intensiva.
- C) Realizar arteriografia e embolização hepática e indicar tratamento não operatório da lesão.
- D) Indicar tratamento não operatório da lesão hepática e realizar nova tomografia abdominal em 24 horas.

64 - Um jovem de 18 anos de idade, está no quarto dia de pós-operatório, de uma esplenectomia após acidente de trânsito. Encontra-se assintomático e não houve intercorrência no pós-operatório. O cirurgião responsável pelo caso, resolve dar alta hospitalar e fazer as orientações. Dentre as diversas orientações pós-operatórias, neste caso deve constar:

- A) Vacina tríplice viral; vacina pentavalente.
- B) Antibioticoterapia para cobertura de bactérias gram-positivas.
- C) Vacina pneumocócica; vacina meningocócica; vacina conjugada anti-Hib.
- D) Antibioticoterapia para cobrir bactéria gram-negativas e anaeróbios.

65 - Uma mulher de 32 anos, vítima de agressão, chega na emergência de um hospital secundário, com queixa de dor torácica a esquerda e em flanco esquerdo. Seus sinais vitais são normais. O exame abdominal é doloroso a palpação profunda de hipocôndrio esquerdo, mas não possui sinais de peritonite. A ausculta respiratória é diminuída em base a esquerda e sua saturação de O₂ é de 94% com máscara de oxigênio a 2 litros/minuto. A radiografia de tórax mostrou um pneumotórax pequeno a esquerda. O ultrassom abdominal evidenciou líquido livre na cavidade peritoneal e imagem sugestiva de lesão esplênica. Não há tomografia computadorizada na instituição. O médico assistente resolve não encaminhar ao Centro de Trauma. A melhor conduta neste caso seria:

- A) Tratamento conservador de pneumotórax oculto e tratamento conservador da lesão esplênica.
- B) Drenagem torácica esquerda e, em seguida, laparotomia exploradora para inventário da cavidade peritoneal.
- C) Tratamento conservador de pneumotórax esquerdo e laparotomia exploradora para inventário da cavidade peritoneal.
- D) Drenagem torácica esquerda e, em seguida, indicar o tratamento não operatório da lesão esplênica.

66 - Um jovem de 21 anos é levado ao centro cirúrgico para laparotomia exploradora, em função de um ferimento por arma de fogo em face anterior do abdômen. Durante a cirurgia, foi evidenciado sangramento ativo oriundo do retroperitônio, em Zona II a direita. A equipe anestésica e cirúrgica resolve ativar o Protocolo de Transfusão Maciça. Após a realização de 1,0 grama de Ácido Tranexâmico, dois Concentrado de Hemácias e dois Plasmas Fresco Congelado, foi realizado uma tromboelastometria que evidenciou a presença de fibrinólise. Diante do achado, a conduta mais adequada seria:

- A) Indicar a infusão de Beriplex.
- B) Indicar a infusão de Hemocomplettam.
- C) Repetir 1,0 grama de Ácido Tranexâmico.
- D) Repetir duas bolsas de Plasma Fresco Congelado.

67 - Um homem de 32 anos chega à sala do trauma após um acidente de moto em alta velocidade. Confuso, com palidez cutâneo mucosa e perfusão periférica lenta, encontra-se instável hemodinamicamente. Iniciado reposição volêmica com Ringer Lactato e solicitado transfusão sanguínea de emergência. O FAST (ultrassom abdominal na sala do trauma) é positivo no espaço hepato-renal e espleno-renal. A radiografia de tórax na sala do trauma evidencia um alargamento de mediastino e apagamento do botão aórtico. A radiografia de quadril é normal. Neste momento, a melhor decisão do líder da equipe cirúrgica seria:

- A) Indicar Laparotomia exploradora.
- B) Encaminhar o paciente para aortografia.
- C) Indicar Tomografia Computadorizada de corpo inteiro.
- D) Manter o paciente na sala do trauma com Protocolo de Transfusão Maciça.

68 - Um senhor de 45 anos está no primeiro pós-operatório de gastrectomia total por uma lesão neoplásica, sem acometimento de outros órgãos. Durante a visita, encontra-se sonolento, pouco atento ao meio externo. A sonda nasogástrica drenou 250 mL e possui apenas um débito de 800 mL na sonda vesical, com diurese concentrada. Com relação às fases do pós-operatório, podemos afirmar que este paciente encontra-se em:

- A) Fase Anabólica e estas alterações acontecem em função da ação do Hormônio Antidiurético e Sistema Renina-Angiotensina.
- B) Fase Catabólica e estas alterações acontecem em função da ação do Hormônio Antidiurético e Sistema Renina-Angiotensina.
- C) Fase Catabólica e as alterações são decorrentes da ação do Cortisol e diminuição da concentração da Insulina.
- D) Fase Anabólica e as alterações são decorrentes da ação do Cortisol e Aumento da concentração da Insulina.

69 - Paciente do gênero masculino, 48 anos, casado, tratorista. Vem para atendimento em unidade básica de saúde devido mal-estar, hiporexia, febre não aferida e perda de 3 kg (Pesava 90 kg). Refere que os sintomas começaram há 4 semanas. Exame físico: BEG, anictérico, descorado 1+/4+. Presença de linfonodomegalia em região cervical anterior à esquerda, de 3,0 cm, outro em região supraclavicular esquerda com 3,0 cm e um linfonodo de 3,0 cm em região inguinal direita. Qual a melhor conduta?

- A) Amoxicilina/clavulanato por 7 dias e reavaliar após 4 semanas.
- B) Encaminhar para biópsia excisional do linfonodo supra clavicular a esquerda.
- C) Prednisona 40 mg por 10 dias e reavaliar biópsia por agulha fina do linfonodo inguinal.
- D) Reavaliar em 3 semanas e se persistência realizar *core biopsy* do linfonodo cervical.

70 - Paciente masculino, 55 anos, branco, diabético e hipertenso há 10 anos, trabalhador rural. Paciente procura atendimento na emergência por dispneia há 4 meses e edema de membros inferiores, que melhoram pela manhã e pioram à tarde. Ao exame físico: BEG, consciente e orientado, descorado 1+/4+, hidratado, eupneico. Pressão arterial de 150x90 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm. Ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem sopros. Ausculta

pulmonar: murmúrio vesicular abolido em bases, frêmito toracovocal diminuído em bases, percussão: submaciço em terços inferiores, bilateralmente. O achado ao exame físico que aumenta a probabilidade do diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva neste paciente é:

- A) Presença de piparote positivo.
- B) Edema com presença de cacifo.
- C) Manobra do refluxo hepatojugular positiva.
- D) Fígado palpável a 8cm do rebordo costal direito.

71 - Paciente de 53 anos, gênero masculino, comerciante, vem em consulta na unidade básica de saúde com quadro de alteração de comportamento há 5 meses e piora nas últimas 3 semanas. Família relatava que o paciente começou a apresentar alterações leves como errar o valor dos produtos que trabalhava, esquecer fatos cotidianos e ultimamente estava trocando os nomes dos produtos e acusando os consumidores de estarem roubando as mercadorias da loja. Negavam histórico de tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas e/ou outras medicações. Apresentava marcha atáxica e trazia alguns exames laboratoriais:

- Hb: 10,0 g/dL (VCM: 110 fL / HCM: 30 pg);
- Ht: 32%;
- Leucócitos: 2.000;
- Plaquetas: 100.000;
- Creatinina: 0,8mg/dL;
- TSH: 1,9 mcUI/mL;
- Ca: 9,5 mg/dL;
- Albumina: 5,0g/L;
- Glicose: 88 mg/dL.

Além da realização de exame de neuroimagem, qual a melhor conduta neste momento?

(Valores de referência: Hb > 13g/dL; Ht: 35 a 45%; VCM: 80 a 100fL; HCM: 28 a 32pg; Albumina: 3,5 a 5,4g/L; TSH: 0,5 a 5,0mcUI/mL; Lo: 4.500 a 10.000; Plaquetas: 150.000 a 450.000; Creatinina: 0,8 a 1,2mg/dL; Glicose: 70 a 105mg/dL; Ca: 8,8 a 10,2mg/dL).

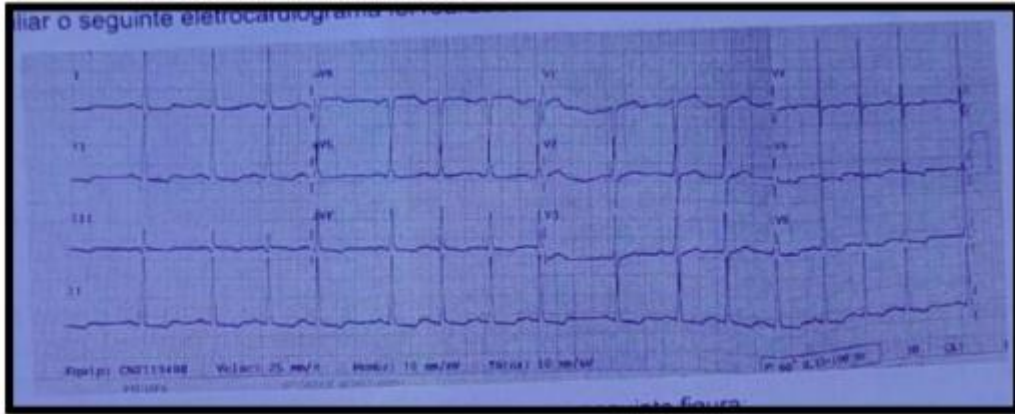
- A) Iniciar Ácido fólico.
- B) Iniciar Prednisona.
- C) Iniciar Cianocobalamina.
- D) Iniciar Penicilina cristalina.

72 - Paciente de 73 anos, gênero masculino, é admitido em unidade de emergência por desorientação em tempo e espaço instalada nas últimas 5 horas. Segundo familiares realiza acompanhamento por neoplasia pulmonar há 1 ano. Ao exame físico neurológico não apresenta déficits sensitivos ou motores. Sinais vitais: PA = 124x78 mmHg, FC = 88 bpm, FR = 18 ipm e afebril; peso:64kg. Glicemia capilar: 88 mg/dL. Tomografia de crânio não apresenta alterações e exames laboratoriais encontram-se dentro da referência exceto pelo sódio de 123mEq/l. Neste contexto qual a melhor conduta?

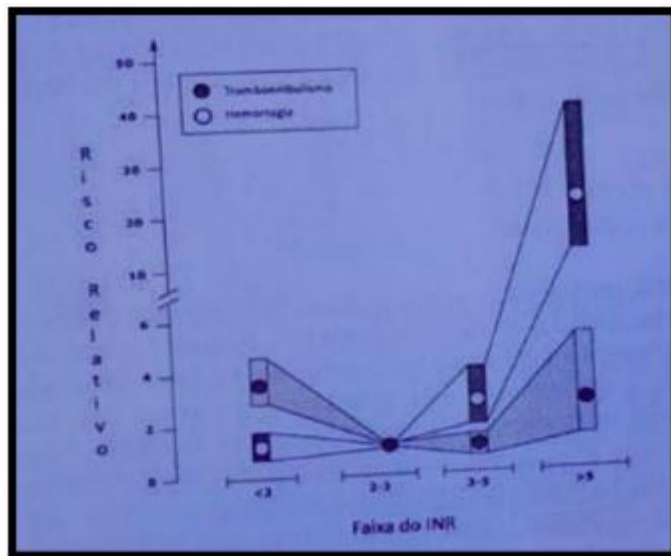
- A) NaCl 20% 10mL + SF 0,9% 90mL EV em 10 minutos.

- B) Solução hipertônica de sódio a 3% 500mL EV em 24h via BIC.
- C) Solução hipertônica de sódio a 3% 1000mL EV em 24h via BIC.
- D) Restrição hídrica exclusiva de 800mL de água até confirmação etiológica.

73 - Paciente de 65 anos, parda, viúva. Hipertensa e diabética. Está internada na enfermaria de clínica médica de um hospital secundário após diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico. Ao exame físico apresenta ritmo cardíaco irregular, bulhas normofonéticas, sem sopros. Restante do exame físico sem alterações. Você está decidindo sobre anticoagulação desta paciente e para te auxiliar o seguinte eletrocardiograma foi realizado:



Após pesquisa na literatura você se deparou com a seguinte figura:



Interprete o gráfico e marque a alternativa correta:

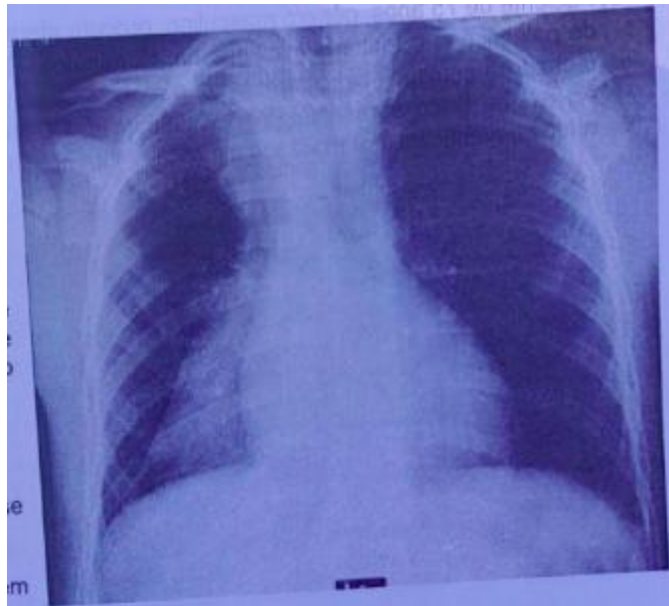
- A) O menor risco de tromboembolismo se inicia com INR > 2.
- B) O maior risco de tromboembolismo se inicia com INR < 3.
- C) O maior risco de sangramento se inicia com INR > 5.
- D) O menor risco de sangramento se encontra na faixa de INR de 3 a 5.

74 - Paciente de 18 anos, gênero feminino, é admitida em unidade de emergência por quadro de discurso inapropriado e agitação psicomotora iniciados há 3 horas. Ao exame físico encontra-se

hipocorada ++/4, desidratada +/+, FC = 100 bpm (ritmo sinusal), altura = 160 cm, peso = 35 kg (IMC = 13,6), desorientada no tempo e espaço, com marcha atáxica e nistagmo horizontal. Realiza acompanhamento ambulatorial com psiquiatra por depressão grave inclusive com comportamento anorético em uso irregular de sertralina. Diante deste caso, como devemos tratar a paciente?

- A) Tiamina EV.
- B) Diazepam EV.
- C) Haloperidol IM.
- D) Cianocobalamina IM.

75 - Homem, 36 anos, internado em hospital regional para tratamento de pneumonia comunitária grave, no sexto dia de ceftriaxona e azitromicina endovenosos. Apresentou 1 pico febril e queixa de mal-estar. Sinais vitais: pressão arterial de 130x80mmHg, frequência cardíaca de 90 bpm, FR: 22 ipm. Exame físico pulmonar: Murmúrio vesicular diminuído em base direita, frêmito diminuído e percussão com macicez em base de hemitórax direito. Foi solicitado o seguinte raio-X de tórax:



Qual a melhor conduta para esse paciente?

- A) Intensificar fisioterapia respiratória.
- B) Enoxaparina 1 mg/kg SC de 12 em 12h.
- C) Posição prona ativa intermitente.
- D) Colher culturas e trocar antibiótico.

76 - Paciente de 65 anos, gênero feminino, diabética tipo 2 é admitida em unidade de emergência por IAM sem supra. Diante dos altos níveis glicêmicos foi optado pela insulinização em Bomba de Infusão Contínua (BIC). A paciente será encaminhada à enfermaria da cardiologia com dieta oral para diabéticos. Recebeu 20 unidades de insulina infundidas nas últimas 6 horas via BIC. Qual seria a prescrição adequada de insulinas NPH e Regular subcutâneas?

- A) Insulina NPH 8:8:8 e insulina regular 8:8:8.

- B) Insulina NPH 10:10:10 e insulina regular 6:6:6.
- C) Insulina NPH 12:12:12 e insulina regular 12:12:12.
- D) Insulina NPH 16:16:16 e insulina regular 10:10:10.

77 - Paciente de 45 anos, gênero masculino, procura atendimento ambulatorial para seguimento de hipertensão arterial diagnosticada há 2 anos. Faz uso regular de Losartan 50 mg/dia e Hidroclorotiazida 25 mg/dia. Traz exame da MAPA com média pressórica ao longo do dia de 145x87 mmHg. Levando-se em conta que o tratamento adequado desta morbidade é composto por medidas farmacológicas e não farmacológicas, entre suas recomendações comportamentais a este paciente teríamos:

- A) Redução da ingesta de laticínios.
- B) Aumento da ingesta de vitamina D.
- C) Aumento da ingesta de sais de potássio.
- D) Redução da ingesta de café e produtos com cafeína.

78 - Paciente de 20 anos, gênero feminino, procura atendimento de emergência por queixas de fraqueza muscular e câimbras há 2 semanas com piora importante na data da admissão hospitalar. Sinais vitais: PA = 114x71 mmHg, FR = 18 ipm, FC = 78 bpm, afebril. Não apresenta disestesias ou alterações em reflexos tendinosos. Exames laboratoriais:

- Hb = 12,5 g/dL;
- Leucócitos totais = 7400/mm³;
- Plaquetas = 180 mil;
- Na = 137 mEq/l;
- K = 2,1 mEq/l;
- Creatinina = 1,0 mg/dL;
- Gasometria venosa:
 - pH = 7,15;
 - HCO₃ = 15;
 - pCO₂ = 28;
 - Glicemia = 98 mg/dL;
 - Cl = 112 mEq/l.
- Urina I:
 - pH = 6,7;
 - Densidade = 1015;
 - Ausência de proteínas, corpos cetônicos, leucocitúria ou hematúria.

Qual diagnóstico poderia justificar o quadro clínico e os achados laboratoriais da paciente?

- A) Amiloidose.
- B) Síndrome de Sjogren.
- C) Síndrome de Bartter.
- D) Hiperaldosteronismo primário.

79 - Paciente de 75 anos, gênero masculino, procura atendimento em unidade de emergência por

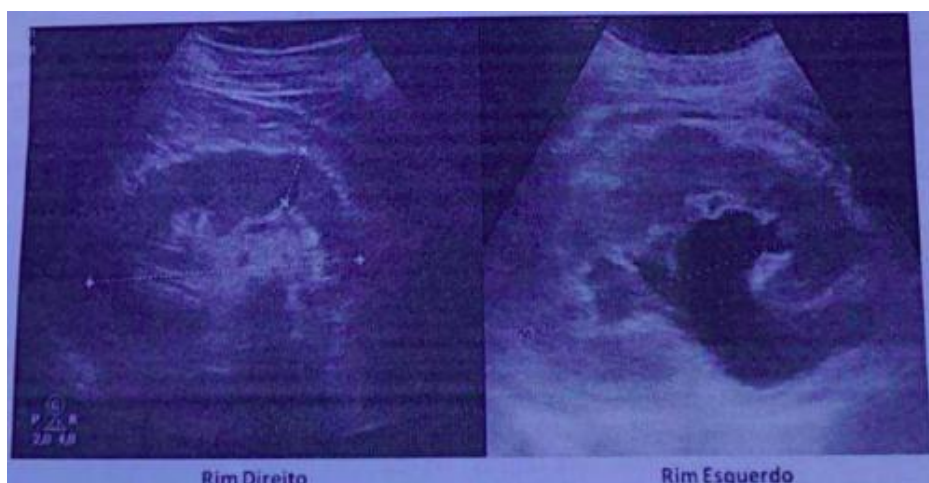
queixa de palpitações e tonturas iniciadas há 45 minutos. Reporta ser hipertenso e dislipidêmico em uso regular de enalapril, hidroclorotiazida e atorvastatina. Relata episódio semelhante a este há 2 anos. Ao exame físico apresenta PA = 135x82 mmHg, FC = 160 bpm, FR = 22 ipm e ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. Foi realizado eletrocardiograma demonstrado abaixo:



Diante deste quadro qual deve ser sua conduta?

- A) Adenosina 6 mg EV.
- B) Metoprolol 5 mg EV.
- C) Angioplastia primária.
- D) Cardioversão elétrica sincronizada.

80 - Paciente de 21 anos, sexo feminino, é admitida em unidade de pronto atendimento de um hospital escola com queixa de dor em flanco esquerdo irradiando para vulva, em uso de ciprofloxacina por conta própria há 1 dia. Ao exame físico se encontra febril e com sinal de Giordano positivo a esquerda. Após analisar a ultrassonografia abaixo, podemos afirmar que a melhor conduta é:



- A) Analgesia com tramadol e dipirona endovenosos.
- B) Solicitar urologia para passagem de cateter duplo J.
- C) Confirmar achado ultrassonográfico com tomografia.
- D) Ceftriaxone em até 6 horas após coleta de culturas.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71
B	C	D	A	A	B	C	C
2	12	22	32	42	52	62	72
D	A	A	A	A	C	B	A
3	13	23	33	43	53	63	73
C	A	C	C	A	D	C	A
4	14	24	34	44	54	64	74
C	C	D	X	X	A	C	A
5	15	25	35	45	55	65	75
A	A	B	A	A	B	B	A
6	16	26	36	46	56	66	76
A	A	D	C	D	B	C	A
7	17	27	37	47	57	67	77
B	A	C	B	C	D	A	C
8	18	28	38	48	58	68	78
D	B	A	A	C	A	B	B
9	19	29	39	49	59	69	79
A	A	C	A	C	C	B	A
10	20	30	40	50	60	70	80
X	C	B	D	D	D	C	B

QUESTÃO ANULADA = X